proregen

GUIA PARA PACIENTES

PRP: o plasma rico em plaquetas

O que é, como é feito e o que a ciência mostra no joelho, no quadril, nos tendões, na coluna e nas feridas. Com honestidade, sem promessas.

Conteúdo educativo. Não substitui a consulta médica.
Baseado em estudos científicos publicados até outubro de 2026.

EDIÇÃO 2026

ANTES DE COMEÇAR

Uma conversa franca sobre o PRP

Talvez você já tenha ouvido falar em tratamento "com o próprio sangue". Este guia explica, em linguagem simples, o que é o PRP, onde ele ajuda, onde ainda está em estudo e onde não mostrou benefício.

O que é o PRP

PRP quer dizer **plasma rico em plaquetas**. As plaquetas são pequenas partes do sangue que ajudam a estancar sangramentos. Elas também liberam substâncias que sinalizam ao corpo que um tecido precisa de reparo.

No PRP, separamos e concentramos essas plaquetas a partir de uma pequena amostra do **seu próprio sangue**. Depois, o concentrado é aplicado no local da lesão.

Por ser feito com material do próprio paciente, o risco de alergia ou rejeição é muito baixo.

COMO LER ESTE GUIA

As bolinhas ●●●○○ mostram a força das evidências científicas em cada área: quanto mais bolinhas, mais segura é a informação.

O PRP **não é cura** e não serve para todos. Ele pode fazer parte de um plano que inclui exercícios, fisioterapia e mudanças de hábito.

01	Como o PRP é feito e o que esperar	3
02	Mapa da evidência, área por área	4
03	Joelho e quadril	5
04	Tendões, ligamentos e ossos	6
05	Coluna e feridas	7
06	Segurança e quem pode ser candidato	8
07	Perguntas frequentes	9
08	Referências e contato	10

Do seu sangue ao local da lesão

O procedimento é feito no consultório ou em sala apropriada e costuma durar menos de uma hora.

1

Avaliação

Consulta, exame físico e revisão dos exames de imagem. É aqui que se decide se o PRP faz sentido para o seu caso.

2

Coleta do sangue

Uma amostra pequena é coletada da veia do braço, como num exame de sangue comum.

3

Preparo

O sangue vai para uma centrífuga, que separa as plaquetas. Existem tipos diferentes de PRP, com mais ou menos glóbulos brancos. O médico escolhe o tipo conforme a lesão.

4

Aplicação

Após assepsia da pele, o PRP é injetado no local, muitas vezes guiado por ultrassom para mais precisão. Em alguns casos são feitas 2 ou 3 aplicações, com semanas de intervalo.

5

Recuperação

É comum sentir dor ou inchaço no local por 2 a 3 dias. Em geral, anti-inflamatórios devem ser evitados nesse período, pois podem atrapalhar a ação das plaquetas. O médico orienta repouso relativo e a volta gradual às atividades.

> O QUE ESPERAR
>
> O PRP não age como um analgésico. Quando funciona, a melhora costuma ser gradual, ao longo de semanas, e o resultado varia de pessoa para pessoa. Nenhum resultado pode ser garantido.

Onde o PRP ajuda, onde ainda não sabemos

Resumo do que os estudos mostram hoje. Ele é um ponto de partida para conversar com o seu médico, não uma indicação.

ÁREA	FORÇA	O QUE OS ESTUDOS MOSTRAM
Joelho com artrose	●●●●○	Boa evidência
Cotovelo de tenista (epicondilite)	●●●●○	Boa evidência
Feridas crônicas	●●●●○	Boa evidência
Tendão patelar	●●●○○	Evidência moderada
Fascite plantar	●●●○○	Evidência moderada
Glúteo médio (dor lateral do quadril)	●●○○○	Resultados conflitantes
Quadril com artrose	●●○○○	Efeito parecido ao do ácido hialurônico
Coluna lombar (disco e facetas)	●●○○○	Em estudo, promissor
Coluna cervical	●○○○○	Em estudo, dados iniciais
Osso e consolidação	●○○○○	Em estudo
Tendão de Aquiles	●○○○○	Sem benefício consistente
Manguito rotador (ombro)	●○○○○	Sem benefício consistente
LCA (ligamento do joelho)	●○○○○	Sem benefício consistente

Os estudos usam tipos diferentes de PRP, números de aplicações e protocolos distintos. Por isso, os resultados nem sempre podem ser comparados entre si.

Articulações que sustentam o seu peso

Joelho com artrose

●●●●○

BOA EVIDÊNCIA

É a área mais estudada. Em artrose leve a moderada, vários estudos mostram melhora da dor e da função, em alguns casos melhor que o ácido hialurônico e a infiltração com corticoide. Costuma ser opção quando exercícios e remédios não bastaram, geralmente em 2 a 3 aplicações. Não regenera a cartilagem perdida.

Glúteo médio (dor na lateral do quadril)

●●○○○

RESULTADOS CONFLITANTES

Estudos de boa qualidade mostraram melhora maior com PRP do que com corticoide no longo prazo. Mas um estudo recente, de 2025, não encontrou diferença entre o PRP e uma injeção de placebo. É um tema em estudo, e os exercícios para fortalecer o quadril seguem sendo a base do tratamento.

Quadril com artrose (coxartrose)

●●○○○

EFEITO MODESTO

Os estudos mostram alívio dos sintomas por até cerca de 6 meses, com resultado parecido ao do ácido hialurônico. Um estudo de 2024 não achou diferença contra soro fisiológico. Por isso, as diretrizes ainda não o recomendam de rotina. Pode ser discutido caso a caso.

Onde funciona e onde não mostrou benefício

Cotovelo de tenista

●●●●○

BOA EVIDÊNCIA

Na epicondilite crônica, há estudos de alta qualidade com melhora da dor e da função no médio prazo, melhor que o corticoide.

Tendão patelar

●●●○○

EVIDÊNCIA MODERADA

Na tendinopatia crônica do joelho, comum em atletas de salto, há melhora funcional em estudos controlados.

Fascite plantar

●●●○○

EVIDÊNCIA MODERADA

Na dor crônica na sola do pé, alguns estudos mostram resultado melhor que o corticoide.

Tendão de Aquiles

●○○○○

SEM BENEFÍCIO CONSISTENTE

Os ensaios clínicos não mostraram benefício de forma consistente. Não é recomendado de rotina.

Manguito rotador e LCA

●○○○○

SEM BENEFÍCIO CONSISTENTE

Usado junto com a cirurgia do ombro ou do ligamento do joelho, o PRP não mostrou melhora clara na cicatrização ou no retorno ao esporte.

Osso e consolidação

●○○○○

EM ESTUDO

Estudos em laboratório e pequenas séries sugerem potencial para ajudar o osso a cicatrizar. Faltam estudos maiores em pessoas.

Áreas em expansão

Coluna lombar

●●○○○

EM ESTUDO, COM PERSPECTIVAS PROMISSORAS

A evidência é melhor para a injeção no disco e nas pequenas articulações da coluna (facetas). Um ensaio clínico e revisões mostram melhora da dor em parte dos pacientes, mas os estudos ainda são poucos e pequenos.

Coluna cervical

●○○○○

EM ESTUDO, DADOS INICIAIS

No pescoço, existem até agora apenas séries de casos. É cedo para saber o real benefício.

Feridas crônicas

●●●●○

BOA EVIDÊNCIA

Uma revisão de 2022, com 29 ensaios clínicos, mostrou chance cerca de 5 vezes maior de a ferida fechar por completo com PRP. A evidência é melhor para úlcera venosa da perna e moderada para pé diabético. Para úlcera de pressão e feridas cirúrgicas, ainda é limitada. Também há bons resultados combinando PRP com curativo a vácuo.

IMPORTANTE

Feridas que não cicatrizam precisam de investigação da causa: circulação, diabetes, infecção. O PRP complementa esse cuidado, não o substitui.

É seguro?
E é para mim?

O PRP é considerado um procedimento de baixo risco, por usar o sangue do próprio paciente.

Efeitos mais comuns

Dor, inchaço ou rigidez no local por alguns dias. Mancha roxa no braço da coleta.

Raros

Infecção no local da aplicação, que é rara quando o procedimento segue técnica estéril.

Procure o médico se houver

- Febre, vermelhidão que se espalha ou calor intenso no local.
- Dor que piora muito depois do terceiro dia.

Pode ser uma opção para quem

Tem diagnóstico confirmado numa área com boa evidência, já tentou o tratamento básico (exercícios, fisioterapia, controle do peso) e entende que o resultado não é garantido.

Em geral não é indicado em casos de

Infecção ativa no local ou no corpo, câncer em tratamento, doenças do sangue ou plaquetas baixas, uso de alguns anticoagulantes, gravidez, e artrose muito avançada, em que outras opções podem ser melhores.

> **DECISÃO COMPARTILHADA**
>
> A melhor escolha é tomada junto com o seu médico, depois de uma avaliação individual.

Dúvidas que ouvimos no consultório

P Dói?

A coleta é como um exame de sangue. Na aplicação, pode haver desconforto e pressão. Nos dias seguintes, a dor local pode aumentar um pouco antes de melhorar.

P Quantas aplicações são necessárias?

Depende da área e da lesão. Em tendões, muitas vezes uma aplicação. No joelho, os estudos costumam usar 2 a 3.

P Quanto tempo dura o efeito?

Varia. No joelho, alguns estudos mostram benefício por 6 a 12 meses. Em outras áreas, os dados são mais curtos.

P Posso trabalhar no dia seguinte?

Na maioria dos casos, sim, com cuidado e sem esforço intenso no local nos primeiros dias.

P O PRP evita cirurgia?

Em alguns casos pode adiar ou reduzir a necessidade, mas isso não pode ser prometido. Há lesões em que a cirurgia continua sendo a melhor escolha.

P PRP é o mesmo que células-tronco?

Não. O PRP usa plaquetas do sangue. Células-tronco e outros ortobiológicos são tratamentos diferentes.

QUER CONVERSAR SOBRE O SEU CASO?

Agende uma avaliação com o Dr. André Kruel, presencial em Bento Gonçalves (RS) ou por consulta online. WhatsApp (54) 99689-1295 · proregen.com.br

De onde vêm estas informações

1. Le ADK et al. Current clinical recommendations for use of platelet-rich plasma. Curr Rev Musculoskelet Med. 2018;11(4):624-634.
2. Sheean AJ, Anz AW, Bradley JP. Platelet-rich plasma: fundamentals and clinical applications. Arthroscopy. 2021;37(9):2732-2734.
3. Litsos S et al. Platelet-rich plasma in the management of musculoskeletal disorders: a narrative review. Front Med. 2026;13.
4. Rothrauff BB et al. Platelet-rich plasma in the treatment of musculoskeletal disease in 2025 and beyond. Am J Sports Med. 2026.
5. Sheth U et al. Efficacy of autologous platelet-rich plasma use for orthopaedic indications: a meta-analysis. J Bone Joint Surg Am. 2012;94(4):298-307.
6. Everts PAM et al. Platelet rich plasma in orthopedic surgical medicine. Platelets. 2021;32(2):163-174.
7. Fitzpatrick J et al. Leucocyte-rich PRP treatment of gluteus medius and minimus tendinopathy: a double-blind RCT. Am J Sports Med. 2019.
8. Atchia I et al. Efficacy of PRP versus placebo for greater trochanteric pain syndrome. J Bone Joint Surg Am. 2025.
9. Topaloglu M et al. PRP versus placebo in hip osteoarthritis. Turk J Phys Med Rehabil. 2024.
10. Zhang D et al. Intra-articular PRP versus hyaluronic acid in hip osteoarthritis: meta-analysis. Pain Res Manag. 2026.
11. Tuakli-Wosornu YA et al. Lumbar intradiskal platelet-rich plasma injections: a prospective, double-blind, randomized controlled study. PM R. 2016;8(1):1-10.
12. Baltzer AW et al. PRP for lumbar facet joint syndrome: CT-guided facet injections. Orthop Rev (Pavia). 2025.
13. Meznerics FA et al. Platelet-rich plasma in chronic wound management: systematic review and meta-analysis of RCTs. J Clin Med. 2022;11(24):7532.

Responsável técnico

Dr. André Kruel · Médico ortopedista

CRM-RS 23627 · RQE 14323

Contato

Proregen · Bento Gonçalves (RS) e consulta online

WhatsApp (54) 99689-1295 · proregen.com.br

Material educativo. Não substitui a consulta médica. Não contém preços, imagens de "antes e depois" ou depoimentos, conforme as regras de publicidade médica do CFM. Edição outubro de 2026.

proregen